- மலச்சிக்கலைதவிர்த்தல்–மலம்கழிக்கும்போது அதிக அழுத்தம் கொடுக்காமல் இருத்தல்
- பளு தூக்கும் போது முழங்கால் மடங்குவதை ஊக்கப்படுத்தி, இடுப்பு மடங்குவதை தவிர்த்தல்.
- அதிகமான பளு தூக்குவதை தவிர்த்தல் (4 – 6 வாரம் சிகிச்சை முடிந்தபின்)

சிக்கல்கள்

1. அடைப்பு: குடலிறக்கம் ஏற்பட்டப் பகுதியில் தொடர்ந்து ஏற்படும் இறுக்கத்தால் குடல் வலி, குமட்டல், வாந்தி மற்றும் இயல்பான குடல் இயக்கங்களும் தடைப்பட்டு, மலம் வெளியேறாமல் அடைப்பு உண்டாகும்.
2. நாள்பட்ட வலி
3. நோய் தொற்று
4. இரத்த ஓட்டம் தடைபடுதல் (ஸ்ட்ரான்குலேஷன்) – குடலிறக்க அடைப்பு மேலும் அதிகரிக்கும் போது தசைப்பகுதியில் அல்லது குடலிறக்கம் உண்டான இடத்தில் இரத்த ஓட்டம் குறைபடுவது ஸ்ட்ரான்குலேஷன் எனப்படும்.
5. மீண்டும் குடலிறக்கம்
6. அடைப்பு மற்றும் ஸ்ட்ரான்குலேஷன் அதிகரிப்பைத் தடுக்க அவசர நிலை அறுவை சிகிச்சை

2.14 மூலநோய் (Haemorrhoids)

முன்னோட்டம்

மூலநோய் என்னும் பைல்ஸ் இரத்த நாளங்கள் பெரிதாவதால் மலக்குடல் மற்றும் ஆசனவாய் உள்ளே அல்லது ஆசன வாயைச் சுற்றிலும் ஏற்படும் வீக்கம்.

வரையறை

மூலநோய் என்பது மலக்குடலின் உட்பகுதி அல்லது ஆசனவாயின் வெளிப்பகுதியில் இரத்த நாளங்கள் விரிவடைந்து பெரிதாவதால் ஏற்படும் அசாதாரண வீக்கம் எனப்படும்.

காரணங்கள்

- மலம் கழிக்கும்போது சிரமப்படுவது
- மலம் கழிக்க நீண்ட நேரம் கழிவறையில் அமர்ந்து இருப்பது.
- நாள்பட்ட வயிற்றுப்போக்கு அல்லது மலச்சிக்கல்.
- உடல் பருமன்
- கர்ப்பம்.
- நார்சத்து குறைந்த உணவு

வகைகள்

- உள்மூலம்
- மலக்குடலின் உட்பகுதியில் ஏற்படுவது
- வெளிமூலம்
- ஆசனவாய் சுற்றிலும் ஏற்படுவது

அடையாளம் மற்றும் அறிகுறிகள்

- மலம் கழிக்கும் போது வலி இல்லாமல் இரத்தம் வருதல்.
- ஆசனவாய் பகுதியில் அரிப்பு அல்லது எரிச்சல் ஏற்படுதல்..
- வலி அல்லது அசௌகரியம் உணர்தல்.
- ஆசனவாயைச் சுற்றிலும் வீக்கம் உண்டாவது.

நோய் கண்டறிதல்

- டிஜிட்டல் மலக்குடல் பரிசோதனை – ஆசனவாய் வழியாக விரலை செலுத்தி மூலநோயின் நிலை, அசாதாரண வளர்ச்சி, மேலும் ஏதேனும் வழக்கத்திற்கு மாறான வீக்கம் கண்டறிதல்.
- பரிசோதனை – குடலின் அடிப்பகுதி மற்றும் மலக்குடலை ப்ராக்டோஸ்கோப் மூலம் பரிசோதித்து அறிதல்.
- பெருங்குடல் பகுதி முழுவதையும் பெருங்குடல் நோக்கு கருவி (கொலனோஸ்கோப்) மூலம் பரிசோதித்து அறிதல்.

மேலாண்மை

- வீட்டு மருத்துவம்.
- நார்சத்து மிக்க உணவு உண்ணுதல் (பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் முழுதானியங்கள்).
- அதிகபடியான திரவம் அருந்துதல். (நீர்)
- ஆசனவாய் பகுதியில் மேல் பூச்சு களிம்பு பயன்படுத்துதல்.
- தினமும் இரண்டு மற்றும் மூன்று முறை 10–லிருந்து 15–நிமிடங்கள் வரை விலாக்குளியல் (Sitz bath) எடுத்துக் கொள்வது(35–37°சி). இளம் சூடாக உள்ள நீரில் மருந்து கலந்து அமர்ந்திருப்பது.
- ஆசனவாய் பகுதியை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளுதல்.
- குளிர்ந்த நீர் அழுத்தம் அல்லது ஜஸ் பேக் முறையை ஆசனவாய் பகுதியில் உள்ள வலி

Unit_2_Medical_Surgery_Gen_Nur_TM.indd 69 06-03-2020 16:49:21